**Établissement**

**Médecin responsable**

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

# Douleur thoracique : ECG en attendant le SAMU

Adulte · 15 d'abord, ECG ensuite

**URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT** · toute douleur thoracique, **même passée** ; ne répond pas, respire anormalement, sueurs et pâleur, malaise, marbrures, détresse respiratoire.

## J'applique si

- Douleur, serrement ou brûlure thoracique, irradiant bras, cou, mâchoire, dos ou épigastre, **même passée**.
- Non communicant : changement brutal de comportement avec sueurs, pâleur ou dyspnée.

## Trinitrine : jamais si

- **PAS < 90 mmHg** ou choc.
- **Sildénafil < 24 h**, **tadalafil < 48 h**, vardénafil récent, riociguat.
- Cardiomyopathie obstructive, IDM du ventricule droit, hypertension intracrânienne (RCP).

## J'agis

ACTES CONSERVATOIRES (R4311-7)

1. **15 d'abord**. Repos strict, demi-assis, à jeun, DSA à proximité, ne pas laisser seul.
2. PA **aux deux bras**, FC, FR, SpO2, T°, glycémie ; heure de début ; anticoagulant, antiagrégant.
3. **O2 seulement si SpO2 < 90 %** (protocole « Dyspnée / Désaturation – Oxygène »).

RÔLE PROPRE

4. **ECG 12 dérivations dans les 10 min**, sans retarder le départ ; transmis au 15 et au médecin (HEALPHI).

SUR ORDRE DU 15

5. **Trinitrine** sur accord du 15 (carte ci-contre) ; PA avant chaque dose.
6. **Aspirine** (molécule, dose, forme fixées par le 15), voie veineuse, antalgique, nouvel ECG.

*Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.*

## Trinitrine (accord du 15)

**Natispray 0,15 mg/dose**

**1 pulvérisation** sous la langue, assis

- Renouveler 1 à 2 fois à 2–3 min si la douleur persiste, sur confirmation du 15
- Arrêt si PAS < 90, malaise, céphalée intense : allonger, rappeler le 15

## J'appelle le médecin

- Après le 15 : médecin de l'établissement, d'astreinte ou DOTR informé, ECG transmis.
- Douleur de paroi sans gravité : avis le jour même.

## Je surveille et je trace

- PA, FC, SpO2, conscience, douleur **toutes les 5 min** jusqu'aux secours ; aggravation : rappeler le 15.
- Heure de début, ECG, trinitrine ou aspirine (dose, heure, PA), consignes reçues.
- **Compte rendu écrit, daté, signé**, remis au médecin (R4311-7).

**À retenir :** Douleur thoracique = 15 d'abord, ECG ensuite, sans retarder les secours. Aucun médicament sans accord du régulateur.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Art. R4311-7 CSP ; arrêté du 26/06/2026 (art. 1 II : ECG 12 dérivations) ; RCP Natispray 0,15 mg/dose (ANSM, MAJ 22/10/2024) ; ESC 2023, syndromes coronariens aigus ; ARS IDF/SGGIF fiche 16 (2016) ; ASSURE IDF fiche 14 (2023) ; OMéDIT CVL, dotations (02/2025).

Réf. DOTR-IDE-THORAX | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature